

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA

Centro Materno-Infantil (sintético) — Hospitalización Obstétrica

FILIACIÓN

Nombre:	PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad:	36 años
Estado civil:	Casada
Ocupación:	Contadora
Fecha de ingreso:	18/04/2026

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G2 P1 (parto vaginal 2022, sin complicaciones). Niega hipertensión, diabetes ni enfermedad renal.

GESTACIÓN ACTUAL

FUM:	20/08/2025
FPP:	27/05/2026
EG actual (por FUM):	34 semanas
Motivo de ingreso:	Oligohidramnios severo
Controles prenatales:	7 al momento

Paciente refiere disminución leve de movimientos fetales en últimos 3 días. Niega pérdida de líquido vaginal, contracciones o sangrado. Eco de control reciente detectó ILA disminuido.

ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA (18/04/2026)

Feto único, vivo, presentación cefálica. Peso fetal estimado 2,050 g (percentil 25). ILA 4 cm (oligohidramnios severo, ILA <5 cm). Doppler arteria umbilical normal. Anatomía fetal sin malformaciones. Placenta posterior grado II.

EXAMEN FÍSICO AL INGRESO

PA 118/74 mmHg. FC 80 lpm. T° 36.6°C. Peso 70.0 kg. AU 30 cm (acorde a EG). LCF 142 lpm. NST reactivo. Sin pérdida vaginal de líquido al examen especular. Test de hehecho negativo.

LABORATORIOS (18/04/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	12.2	g/dL	Dentro de rango
Creatinina	0.7	mg/dL	Normal
Urea	22	mg/dL	Normal
Glucosa basal	90	mg/dL	Normal
Examen de orina	Normal	—	Sin proteinuria

PLAN

1. Hospitalización para vigilancia materno-fetal. 2. Maduración pulmonar fetal con betametasona 12 mg IM c/24 h x 2 dosis. 3. Hidratación oral 2-3 L/día. Hidratación IV si tolerancia oral pobre. 4. Monitoreo fetal con NST cada 24 horas y eco con ILA cada 48 horas. 5. Considerar interrupción del embarazo a las 36-37 semanas si oligohidramnios persiste, o antes si aparecen signos de compromiso fetal. 6. Interconsulta con perinatología.